Protocolo de validación inclusiva

CONTIGO APF 3. Instrumento para completar antes y durante sesiones reales. Los campos vacíos no representan datos recogidos.

Preparación obligatoria

Fijar versiones y caso de prueba, verificar acceso, asignar roles y probar la tecnología de apoyo del participante. Acordar contacto del responsable, plazo de conservación, lugar de almacenamiento y procedimiento de retiro antes de solicitar consentimiento.

Campo	Registro
Responsable y contacto	_____
Versiones v2.0 yv 3.0	_____
Fecha y dispositivo	_____
Perfil y tecnología usada	_____
Datos reales o simulación declarada	_____
Orden de versiones y tareas	_____

Guion uniforme

Estamos evaluando la aplicación. Usaremos datos ficticios. Puede detenerse o pedir una pausa cuando lo desee. No necesita revelar ninguna condición de salud. Mientras realiza la tarea, diga qué busca y qué espera que ocurra. Leeré la consigna y observaré sin indicar dónde pulsar. Si solicita ayuda, la registraré antes de intervenir.

Hipótesis a fijar antes: éxito autónomo al menos 80% por tarea y perfil y SUS al menos 68. Registrar los intentos fallidos y la ayuda por separado. No excluirlos para mejorar las medias. No imponer un límite que impida el uso de tecnología de apoyo.

Tareas y reglas de medición

T1 Paciente

Imagine que ya tomó Losartán 50 mg de las 08:00. Registre esa respuesta.

Inicio. Vista única del paciente, medicamentos y mediciones; dosis sin responder.

Cierre. La dosis correcta queda respondida y la persona identifica el estado guardado.

T2 Paciente

Imagine que necesita pedir ayuda. Localice el SOS de prueba y explique su confirmación.

Inicio. Vista única paciente, SOS superior.

Cierre. Completa el flujo de demostración y distingue registro de solicitud de entrega efectiva.

T3 Cuidador

Revise el tratamiento e indique las unidades disponibles y cuándo es la próxima cita.

Inicio. Resumen del cuidador, mismo paciente seleccionado.

Cierre. Los tres datos coinciden con el caso sintético y se reconoce la procedencia.

T4 Paciente

Ingrese una lectura con un dato obligatorio vacío o con el número de abajo mayor al de arriba. Corrija, revise y guarde.

Inicio. Vista única paciente, sección Registrar medición.

Cierre. Identifica el campo, conserva los valores válidos, corrige, revisa y confirma una sola medición.

Inicio del cronómetro: final de la consigna. Fin: criterio de cierre, abandono o detención. Registrar por separado pausas y ayuda. SEQ: qué tan fácil o difícil resultó la tarea,1 muy difícil a 7 muy fácil. SUS después de cada versión, antes de discutir respuestas.

Consentimiento informado

Estudio académico de accesibilidad de CONTIGO. Completar los datos del responsable y las condiciones de tratamiento antes de presentar esta hoja. No usarla como consentimiento ya otorgado.

Se me invita a realizar tareas con información sintética para evaluar una interfaz. Mi participación es voluntaria y puedo pausar o retirarme sin consecuencias. No necesito revelar un diagnóstico. La actividad no presta atención médica ni evalúa mis capacidades.

El equipo registrará acciones, tiempos, errores y respuestas de cuestionarios bajo un código. Mis datos de identidad se conservarán por separado. Las capturas se revisarán para evitar información personal. No se grabará audio o vídeo sin mi autorización específica.

Información que debe proporcionar el equipo	Dato
Responsable y contacto para consultas o retiro	_____
Finalidad y uso de resultados	Trabajo académico APF 3
Lugar de almacenamiento y personas con acceso	_____
Plazo de conservación y fecha de eliminación	_____
Cómo solicitar acceso rectificación o retiro	_____

He recibido una explicación comprensible y puedo hacer preguntas. Autorizo participar: Sí [ ] No [ ].

Autorización separada para grabación de audio: Sí [ ] No [ ].
Autorización separada para vídeo o imágenes: Sí [ ] No [ ].
Negarme a grabar no impide mi participación.

Código participante _____ Fecha _____
Firma o forma accesible de consentimiento _____
Nombre y firma de quien informa _____

Conservar el consentimiento original en carpeta privada. Los anexos académicos deben usar una copia anonimizada o un registro de consentimiento sin identidad. Evitar firmas y contactos en un ZIP público.

Ficha de observación de una sesión

Campo	Registro
Código participante y consentimiento registrado	_____
Fecha evaluador versión y orden	_____
Dispositivo navegador resolución zoom	_____
Perfil tecnología de apoyo experiencia	_____
Tarea y pantalla inicial	_____
Tiempo total y pausas en segundos	_____
Resultado autónomo con ayuda fallo abandono	_____
Errores y ayuda solicitada	_____
SEQ 1 a 7 y comentario literal autorizado	_____
Barrera criterio severidad evidencia	_____

Observación libre

_____

_____

_____

_____

Anotar lo observado sin atribuir diagnósticos ni intenciones. Diferenciar cita literal, interpretación del evaluador y resultado comprobado. Guardar el identificador de captura o registro y la versión.

Cuestionario SUS y pregunta SEQ

Código _____ Versión _____ Fecha _____
Mantener esta redacción uniforme en todas las sesiones. Responder cada ítem de 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo.

Ítem	Enunciado	Respuesta 1 a 5
1	Me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.	_____
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	_____
3	Me pareció que el sistema fue fácil de usar.	_____
4	Creo que necesitaría ayuda técnica para usarlo.	_____
5	Las funciones estaban bien integradas.	_____
6	Había demasiada inconsistencia en el sistema.	_____
7	La mayoría de personas aprendería a usarlo muy rápido.	_____
8	Encontré el sistema muy engorroso de usar.	_____
9	Me sentí seguro al utilizar el sistema.	_____
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarlo.	_____

Puntuación SUS: sumar respuesta menos 1 en los ítems impares y 5 menos respuesta en los pares. Multiplicar la suma por 2.5. El resultado va de 0 a 100 y no es un porcentaje. No calcular si falta algún ítem.

SEQ después de cada tarea: En general ¿qué tan difícil o fácil le resultó esta tarea?
1 Muy difícil [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 [ ]6 [ ]7 Muy fácil [ ]

La hoja XLSX calcula puntuaciones solo cuando están completas las respuestas. El equipo conserva las fichas originales. El cuestionario acompaña las observaciones, no reemplaza la prueba de accesibilidad.

Registro con tecnología de apoyo

Una captura del árbol de accesibilidad o una ejecución automática no equivale a escuchar y operar con un lector de pantalla. Registrar la herramienta real, su versión y el recorrido.

Condición	Registro y resultado
Teclado	Tab yShift+Tab recorren controles. Enter oEspacio activan. Escape cierra. Foco visible y retorno correcto. Evidencia: _____
Zoom nativo 200%	Configurar el zoom del navegador. Verificar texto, controles, desplazamiento y recuperación. No sustituir por zoom CSS. Evidencia: _____
Lector NVDA u otro	Registrar versión, navegador, modo de navegación y lectura. Revisar nombre, rol, estado, encabezados y errores en T1-T4. Evidencia: _____
Uso sin audio	Silenciar y completar T1-T4. Los estados e instrucciones deben ser visibles. Evidencia: _____
Stark en Figma	Registrar ratios por pareja y estado. Capturas de protanopia, deuteranopia y tritanopia. Evidencia: _____
Orientación y espaciado	Probar vertical horizontal y espaciado requerido sin perder contenido ni funciones. Evidencia: _____

Criterio de registro

Por cada barrera anotar pantalla, acción, expectativa, resultado, criterioWCAG, severidad y captura. Una prueba sin fallo detectado cubre únicamente las condiciones ejecutadas. Indicar expresamente lo no evaluado.

Guion de sustentación de doce minutos

Bloque	Tiempo	Qué mostrar
Contexto y alcance	1 min	Caso, roles, perfiles y tareas conservadas.
Auditoría	2.5 min	Métodos, matriz y tres hallazgos con evidencia.
Ajustes	2.5 min	Antes/después, criterio y resultado de nueva prueba.
Demostración	3 min	Modo alto contraste o texto ampliado, teclado, error y recuperación.
Validación	2 min	Participantes, métricas y barreras. Si falta evidencia declararlo.
Conformidad	1 min	Estado parcial, excepciones y plan.

La consigna suma estos bloques a 12 min. Ensayar con cronómetro e incluir la transición entre integrantes. Reservar otros 3 min para preguntas.

Antes de entregar

Verificar enlace Figma en incógnito, matriz con 26 criterios núcleo documentados, nueve ajustes con evidencia, solución de prioridades altas, consentimientos anonimizados, métricas completas y declaración de IA. Revisar límites de 15 páginas de cuerpo y 12 diapositivas.

Preguntas de defensa

¿Qué tarea impide la barrera y para quién? ¿Por qué asignaron esa severidad? ¿Qué evidencia prueba el criterio? ¿Qué cambió con el ajuste? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué datos proceden de personas y cuáles son comprobaciones técnicas o simulaciones?